

Nódulos benignos y fibroadenoma

1. Introducción y relevancia clínica

Los **nódulos mamarios benignos** son un motivo de consulta extremadamente común en atención primaria y control ginecológico.

Aunque la mayoría son benignos, siempre deben evaluarse con un enfoque sistemático para **descartar cáncer de mama**, el cual puede presentarse de forma similar.

El **fibroadenoma** es el **tumor benigno más frecuente de la mama** en mujeres jóvenes. Representa hasta el **60–70% de las masas sólidas en mujeres menores de 30 años**.

□ En EUNACOM suelen preguntar:

- Qué estudios pedir ante un nódulo mamario palpable.
 - Cuándo observar y cuándo biopsiar.
 - Cómo diferenciar fibroadenoma de cáncer.
 - Qué significa una categoría **BI-RADS 2, 3 o 4** en la mamografía/ecografía.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Fisiopatología general

Los nódulos benignos derivan de **proliferaciones no neoplásicas** o **neoplasias benignas** del epitelio y estroma mamario.

Su crecimiento depende de la **influencia hormonal (estrógenos y progesterona)** y suele ser **fluctuante con el ciclo menstrual**.

b. Fibroadenoma

Es un **tumor mixto** (epitelial y estromal) con cápsula bien definida.

- Estimula el crecimiento por **estrógenos** (por eso es más frecuente en adolescencia y edad fértil).
- Puede **aumentar durante el embarazo o terapia hormonal**.

- El fibroadenoma NO es precanceroso, pero puede coexistir con carcinoma (raro).
-

3. Epidemiología

- Incidencia máxima: 15–35 años.
 - Bilateral en 10–20% de los casos.
 - Múltiples en 15–25%.
 - En Chile, la mayoría de los nódulos en mujeres jóvenes corresponden a fibroadenomas o cambios fibroquísticos.
-

4. Clínica

a. Fibroadenoma típico

- Nódulo **móvil, elástico, bien delimitado**.
- Tamaño: 1–3 cm (puede crecer hasta >5 cm = *fibroadenoma gigante*).
- Sin retracción cutánea ni secreción.
- Puede aumentar de tamaño en embarazo o lactancia.
- Generalmente **indoloro**, aunque puede molestar en fase lútea.

b. Otras lesiones benignas

Lesión	Características clínicas
Quiste simple	Fluctuante, blando, puede doler antes de menstruación.
Cambios fibroquísticos	Dolor y nodularidad difusa, bilateral, cíclica.

Papiloma intraductal Secreción serosa o sanguinolenta por pezón.

Lipoma / hamartoma Masa blanda, móvil, no dolorosa.

☐ La **movilidad** del nódulo y la **ausencia de retracción cutánea o linfonodos** son los principales signos de benignidad.

5. Diagnóstico diferencial

Característica	Benigno	Maligno
Borde	Regular, bien delimitado	Irregular o espiculado
Movilidad	Libre	Fijo a piel o plano profundo
Dolor	Presente o ausente	Habitualmente indoloro
Piel	Normal	Retracción, ulceración, piel de naranja
Crecimiento	Lento	Rápido o progresivo
Adenopatías	Ausentes	Presentes, firmes, fijas

☐ Siempre debe confirmarse con **imágenes**: no basta el examen físico.

6. Exámenes complementarios

a.

Evaluación por edad (según MINSAL)

Edad	Examen inicial	Complemento
<30 años	Ecografía mamaria	—
30–40 años	Ecografía + Mamografía	—
>40 años	Mamografía bilateral	Ecografía si duda

La **ecografía** distingue **lesiones sólidas (fibroadenoma)** de **quísticas**, y evalúa márgenes, vascularización y BI-RADS.

b.

Sistema BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System)

Categoría	Descripción	Conducta
0	Estudio incompleto	Requiere evaluación adicional
1	Normal	Control rutinario
2	Lesión claramente benigna	Control habitual
3	Probablemente benigna (<2% riesgo)	Control imagenológico en 6 meses
4	Sospechosa (2–95%)	Biopsia con aguja gruesa

5	Altamente sospechosa (>95%)	Derivar a cirugía oncológica
---	-----------------------------	------------------------------

6	Confirmada malignidad	Manejo oncológico
---	-----------------------	-------------------

☐ En el caso del **fibroadenoma típico**, la categoría habitual es **BI-RADS 2 o 3**.

c.

Ecografía mamaria

Características del **fibroadenoma típico**:

- Masa sólida ovalada, hipoecoica.
- Ejes paralelos a la piel ("wider than tall").
- Bordes bien definidos.
- Homogénea.
- Sin aumento de flujo Doppler.

Si tiene bordes irregulares, heterogéneos o microcalcificaciones → sospechar malignidad.

d.

Biopsia con aguja gruesa (core biopsy)

Indicada cuando:

- Lesión **>2 cm** o crecimiento progresivo.
- Categoría **BI-RADS 4 o 5**.
- Dudas diagnósticas.
- Paciente >35 años.

Permite confirmar diagnóstico histológico (fibroadenoma, quiste complejo, etc.).

7. Manejo clínico

a.

Fibroadenoma confirmado

Situación	Conducta
<2 cm, asintomático, BI-RADS 2–3	Observación y control ecográfico anual
>2–3 cm, sintomático o en crecimiento	Extirpación quirúrgica (tumorectomía)
Múltiples o bilaterales	Manejo individualizado
Fibroadenoma gigante (>5 cm)	Resección quirúrgica por sospecha de filodes
La mayoría no requiere cirugía y puede controlarse ambulatoriamente.	

b.

Cambios fibroquísticos

- Reasegurar benignidad.
 - AINEs o suplementos de vitamina E (opcional).
 - Sujetador adecuado.
 - Control anual.
-

c.

Quistes simples

- Confirmar por ecografía.
 - Si >3 cm o sintomático → punción evacuadora.
 - Si contenido hemático o recidiva → estudio histológico.
-

d.

Papiloma intraductal

- Requiere **resección quirúrgica del conducto afectado**, por riesgo de carcinoma in situ.
-

8. Complicaciones

Lesión	Complicación posible
Fibroadenoma	Crecimiento rápido (fibroadenoma gigante)
Cambios fibroquísticos	Dolor crónico
Quistes complejos	Infección o hemorragia
Papiloma intraductal	Riesgo de carcinoma ductal in situ
Lesiones múltiples	Dificultan seguimiento mamográfico

9. Pronóstico

- Los nódulos benignos tienen **pronóstico excelente**.
 - La mayoría de los fibroadenomas **no recidivan tras extirpación**.
 - No aumentan el riesgo de cáncer, salvo variantes atípicas (raro).
-

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El **fibroadenoma** es el nódulo benigno más frecuente en mujeres jóvenes.
2. **Móvil, elástico, indoloro, bien delimitado**.
3. **Ecografía mamaria** es el examen de elección <30 años.
4. Si el nódulo tiene **características típicas y <2 cm**, se **observa**.
5. **BI-RADS 3 → control a 6 meses; BI-RADS 4–5 → biopsia**.
6. En >40 años, siempre agregar **mamografía bilateral**.
7. Si crece o duele, considerar **extirpación quirúrgica**.



Errores comunes

- Realizar cirugía innecesaria ante fibroadenoma típico y pequeño.
 - No pedir mamografía en mujeres >40 años.
 - Omitir seguimiento en BI-RADS 3.
 - No diferenciar quiste simple (anecoico) de masa sólida.
 - Ignorar secreción hemática (puede ser signo de papiloma o carcinoma).
-

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **fibroadenoma** es el **tumor benigno más frecuente** en mujeres jóvenes.
2. Clínicamente: **masa móvil, elástica, indolora**.
3. **Ecografía mamaria** distingue lesiones sólidas de quísticas.
4. **BI-RADS 3**: control a 6 meses; **BI-RADS 4–5**: biopsia.
5. La mayoría se **maneja de forma conservadora**.
6. **Mamografía** es obligatoria >40 años.
7. Pronóstico excelente; no aumenta riesgo de cáncer.